

Памятка пациенту: атипичные антидепрессанты

Миртазапин, бупропион, тразодон, агомелатин, вортиоксетин

О чём эта памятка

«Атипичные» антидепрессанты — препараты с механизмами, отличными от СИОЗС/СИОЗСН. Часто применяются при плохой переносимости, специфических симптомах или в комбинации. К ним относятся: миртазапин (Remeron), бупропион (Wellbutrin), тразодон (Trittico), агомелатин (Valdoxan), вортиоксетин (Brintellix).

Кому что подходит: краткая карта

Препарат	Дозы	Особенности и «ниша»
Миртазапин	15–45 мг на ночь	Седирует, повышает аппетит и вес. Хорош при инсомнии, потере веса и аппетита, ажитированной депрессии. Мало сексуальных побочных эффектов.
Бупропион	150–300 мг утром (XR)	Активирует, помогает при апатии и усталости. Не даёт сексуальных побочных, часто снижает вес. Помогает бросить курить. Противопоказан при судорогах, булимии/анорексии.
Тразодон	25–150 мг на ночь (для сна); 150–300 мг (депрессия)	В малых дозах — распространённое средство от бессонницы. В больших — АД. Мало сексуальных побочных. Редко — приапизм у мужчин.
Агомелатин	25–50 мг на ночь	Мелатониновый агонист + 5-HT _{2C} -антагонист. Хорошо восстанавливает сон, минимум сексуальных побочных, нейтрален по весу. Требуется контроль печёночных ферментов (АЛТ/АСТ на 3, 6, 12, 24 неделе).
Вортиоксетин	5–20 мг утром	Мультимодальный (SERT + 5-HT рецепторы). Улучшает когнитивные функции. Мало сексуальных побочных.

Что МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ

✓ Можно

- Принимать в назначенное врачом время (миртазапин, тразодон, агомелатин — вечером; бупропион, вортиоксетин — утром).
- Продолжать работу и вождение при стабильной дозе.
- Сочетать с психотерапией.
- Бупропион — совместим со многими СИОЗС (комбинированная схема).

✗ Нельзя

- ИМАО — со всеми препаратами группы.
- Бупропион при судорогах в анамнезе, ЧМТ, булимии/анорексии, резком отказе от алкоголя/бензодиазепинов (снижает порог судорожной готовности).
- Агомелатин при тяжёлой печёночной недостаточности и без контроля печёночных ферментов.
- Резко бросать (кроме агомелатина — у него синдром отмены практически отсутствует).

! С осторожностью

- Алкоголь: усиливает седацию мirtазапина и тразодона. С агомелатином — риск для печени. С бупропионом — снижает порог судорог.
- Грейпфрут — влияет на метаболизм вортиоксетина, тразодона, мirtазапина через CYP3A4.
- Триптаны, трамадол — с вортиоксетином осторожно (риск серотонинового синдрома).
- Бупропион ингибирует CYP2D6 — меняет уровни метопролола, кодеина, тамоксифена и др.

Побочные эффекты (специфика по препаратам)

Препарат	Типичные эффекты
Миртазапин	Сонливость (особенно на 15 мг, парадоксально меньше на 30–45 мг), повышение аппетита и веса, сухость во рту. Редко: агранулоцитоз.
Бупропион	Тревога, сухость во рту, инсомния (принимать утром), головная боль, снижение аппетита. Судороги: < 0,1% на дозе до 300 мг.
Тразодон	Сонливость, головокружение, ортостатическая гипотензия. Редко: приапизм (при появлении длительной эрекции > 4 ч — срочно к врачу).
Агомелатин	Головная боль, тошнота, головокружение. Повышение печёночных ферментов — контроль АЛТ/АСТ по схеме.
Вортиоксетин	Тошнота (наиболее частый эффект, обычно проходит), рвота. Минимум сексуальных побочных.

⚠ Когда СРОЧНО связаться с врачом или вызвать скорую (103 / 112)

- Мысли о самоповреждении или суициде, особенно с планом.
- Резкое возбуждение, агитация, спутанность сознания.
- Высокая температура + мышечная ригидность + потливость + дрожь + тахикардия (подозрение на серотониновый синдром).
- Сильная сыпь, отёк лица/губ, затруднённое дыхание (аллергия).
- Кровотечения: длительное носовое, кровь в стуле, обильные синяки.
- Судороги, обморок, необычно медленный или частый пульс.
- Резкое усиление тревоги/панические атаки в первые 1–2 недели (может потребоваться коррекция дозы или временное «прикрытие»).

Вождение автомобиля

- Миртазапин, тразодон — выраженная седация, особенно в первые 2 недели. Утренняя «остаточная» сонливость возможна. Вождение — только при уверенности в бодрствовании.
- Бупропион, вортиоксетин — не седируют; при стабильной дозе вождение не ограничено.

- Агомелатин — минимально влияет на когнитивные функции утром (эффект уходит с ночью).

Беременность

! Позиция руководства

При инициации терапии в беременности предпочтительны СИОЗС (сертралин). Атипичные АД — при неэффективности/непереносимости.

- Бупропион — умеренный объём данных, без выраженной тератогенности. Полезен при сопутствующем табакокурении.
- Миртазапин — данных ограничено, но без чёткого сигнала о вреде.
- Вортиоксетин, агомелатин — данных мало; обычно избегать.
- Тразодон — в малых дозах для сна применяется, серьёзных сигналов нет.

Источники: MotherToBaby, Eleftheriou 2023, LactMed.

Грудное вскармливание

✓ Совместимость

- Миртазапин — низкие уровни в молоке, считается совместимым (LactMed).
- Бупропион — низкие уровни; описан единичный случай судорог у младенца — наблюдение обязательно.
- Тразодон — совместим (кратковременный приём, низкая RID).
- Вортиоксетин, агомелатин — данных недостаточно, обычно предпочитают проверенные препараты (сертралин).

Отмена

- Миртазапин — умеренный синдром отмены (нарушения сна, тошнота). Снижение по 15 мг каждые 2 недели.
- Бупропион — синдром отмены минимален; всё равно снижать плавно 2-4 недели.
- Тразодон — при коротком курсе для сна можно отменить сразу; при длительной АД-дозе — постепенно.
- Агомелатин — синдром отмены практически отсутствует, можно отменять быстро.
- Вортиоксетин — благодаря длинному $T_{1/2}$ (66 ч) отмена мягкая.

Развенчание мифов

Развенчание мифов

Миф: «Миртазапин — «снотворное»»

На самом деле: Нет, это полноценный антидепрессант с седативным профилем. Сон улучшается уже с первых дней, антидепрессивный эффект — как у остальных АД, к 4–6 неделе.

Миф: «Бупропион — «весёлые таблетки» / стимулятор»

На самом деле: Нет. Он не даёт эйфории. Активирует ровно настолько, чтобы убрать апатию и усталость. Не относится к веществам с потенциалом злоупотребления в терапевтических дозах.

Миф: «Агомелатин — «мелатонин» и всё»

На самом деле: Он агонист MT1/MT2 плюс антагонист 5-HT2C, что и создаёт антидепрессивный эффект — не сводится к снотворному.

Миф: «Вортиоксетин — «улучшает мозг»»

На самом деле: Он улучшает когнитивные симптомы в рамках депрессии — не является ноотропом для здоровых людей.

Частые вопросы

? Частые вопросы (FAQ)

Миртазапин заставит меня набрать вес?

У части пациентов — да, особенно в первые месяцы. Помогает контроль порций, регулярная активность. При выраженной прибавке — обсудить смену на бупропион или вортиоксетин.

Бупропион правда помогает бросить курить?

Да — есть отдельная зарегистрированная форма (Zyban). Эффект сохраняется и на «депрессивной» форме Wellbutrin.

Тразодон 50 мг «для сна» — это лечение депрессии?

Нет. В таких дозах — только снотворный эффект. Для антидепрессивного эффекта нужны дозы 150–300 мг.

Почему при агомелатине надо сдавать печёночные пробы?

Редко (< 1%) даёт бессимптомное повышение АЛТ/АСТ. Стандартный график: до начала, на 3, 6, 12 и 24 неделе, затем при повышении дозы.

Вортиоксетин совместим с алкоголем?

Как и все АД — лучше избегать. Прямых запретов нет, но алкоголь снижает эффективность лечения.

Питание и образ жизни

Антидепрессант работает лучше, если помогать ему извне. Ниже — то, что имеет доказательную базу (не БАДы, не «волшебные» диеты).

Питание

- Средиземноморский тип питания (овощи, рыба, оливковое масло, бобовые, цельные злаки, орехи) — единственный тип питания с доказанным умеренным антидепрессивным эффектом (SMILES trial, 2017; PREDIMED).

- Омега-3 (жирная рыба 2 раза в неделю) — вспомогательный эффект при депрессии, особенно EPA-обогащённые формы.
- Регулярность приёмов пищи: пропуск еды усиливает тошноту и головокружение от многих АД.
- Достаточно воды (1,5–2 л/сут) — уменьшает сухость во рту и запоры.

Кофеин и энергетики

- До 200–300 мг кофеина в сутки (2–3 чашки кофе) — обычно безопасно.
- При выраженной тревоге и бессоннице лучше отказаться от кофе после 14:00.
- Энергетики и предтренировочные комплексы нежелательны — содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, усиливают тревогу и сердцебиение.

Сон

- Ложиться и вставать в одно и то же время (± 30 мин), даже в выходные.
- Экран за 30–60 минут до сна — выключить. Синий свет подавляет мелатонин.
- Если препарат бодрит (флуоксетин, венлафаксин, бупропион) — принимать утром. Если седирует (миртазапин, тразодон, амитриптилин, пароксетин) — вечером.

Физическая активность

- 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед) — эффект сопоставим с лёгкими формами депрессии на монотерапии (Cochrane, 2013; meta-analyses 2023).
- Силовые тренировки 2 раза в неделю — дополнительный эффект на тревогу и самооценку.
- Начинать с малого: 10 минут в день — уже работает.

Дисклеймер. Этот документ — информационная памятка, а не медицинская инструкция. Все решения о начале, изменении дозы и отмене препарата принимаются только совместно с лечащим врачом. Материал подготовлен на основе современных источников: NICE NG222 (2022–2024), APA Practice Guidelines, WFSBP, Maudsley Prescribing Guidelines (14-е изд.), NIH LactMed, MotherToBaby, Cochrane Reviews.